

RECURSO CÍVEL Nº 5060388-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: JHONATAN LIMA MARQUES (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRENTE: CLAYTON DE BARROS MARQUES (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE INSUMO - DIABETES MELLITUS 1 - SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE - INSUMO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - RESERVA DO POSSÍVEL - AUSENCIA DE PROVA DE REJEIÇÃO AO TRATAMENTO PADRONIZADO - REGISTRO NA ANVISA - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - TEMA 106 DO STJ - **O TESTE DE REFERÊNCIA PRECONIZADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (AUTOMONITORIZAÇÃO CONVENCIONAL) ESTÁ COBERTO PELO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR E QUE O EQUIPAMENTO GLICOSÍMETRO CAPILAR E OS INSUMOS TIRAS REAGENTES E LANCETAS ESTÃO PADRONIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO ÂMBITO DO SUS, OBJETIVANDO O CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DEPENDENTES DE INSULINA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.**

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5060388-66.2024.4.02.5101

510015013638 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5060388-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: JHONATAN LIMA MARQUES (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRENTE: CLAYTON DE BARROS MARQUES (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os contracheques apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

***ENUNCIADO 119** - "O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50." (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).*

Em suma, a pretensão consiste na concessão dos insumos Monitor FreeStyle® Libre e Sensores FreeStyle Libre®.

De acordo com laudo médico, emitido em 06 de junho de 2024, pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado, a parte autora possui o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, desde 2015, com abertura do quadro com cetoacidose diabética (fl. 18 do evento 1, ANEXO2):

LAUDO MÉDICO

Jhonatan Lima Marques, 17 anos e 5 meses, registro 1653626, é portador de Diabetes Mellitus 1 (CID E10) desde 2015, com abertura do quadro com cetoacidose diabética. Diabetes é doença crônica e se mal controlada pode gerar complicações agudas (cetoacidose diabética e hipoglicemia com crise convulsiva, coma e sequelas neurológicas) e crônicas (cegueira, insuficiência renal e doença vascular periférica). Para bom controle necessita de múltiplas monitorizações da glicemia capilar e insulinização, consultas regulares mensais com endocrinologista e nutricionista, além de dieta rigorosa.

Paciente sempre apresentou boa adesão ao tratamento proposto, fazendo contagem de carboidrato e faz uso de análogos de ação ultra longa e ultra rápida. Apesar disso continua apresentando labilidade glicêmica importante e apresentou episódio de hipoglicemia grave com crise convulsiva.

Para melhor monitorização e segurança do paciente solicito a liberação do sensor de glicemia FreeStyle Libre® para o paciente acima (1 sensor a cada 14 dias – uso contínuo), na tentativa de melhorar de controle e diminuir o risco de novos de hipoglicemia grave que pode levar a sequelas neurológicas.

À disposição para mais esclarecimentos,



Médica do Ambulatório de Endocrinologia pediátrica do HFSE

O juízo de origem julgou **improcedente o pedido**.

Em sede recursal, a recorrente pugna pela reforma da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que a obrigação da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária, de maneira que qualquer um dos referidos entes federativos pode figurar no polo passivo de demanda em que se objetiva assegurar o fornecimento ou custeio de medicamentos ou tratamento médico. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF, Pleno, RE 855178 RG/PE, Relator Ministro LUIZ FUX, publicado em 16/03/2015).

Além disso, o entendimento quanto à legitimidade da União e, *mutatis mutandis*, também dos demais entes federados encontra-se, inclusive, sedimentado no Enunciado nº 43 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais desta Seção Judiciária do Rio de Janeiro, *in verbis*:

Enunciado 43: “A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS”.

A descentralização administrativa dos serviços e recursos financeiros tem por fim tão somente o de melhorar a qualidade e o acesso à saúde, e não pode se prestar para afastar a responsabilidade de quaisquer dos entes. Pelo contrário, reforça a responsabilidade solidária, pois indica o trabalho conjunto para perseguir o fim constitucional.

O exame da questão passa pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, na STA em AgRg 175, onde aquele explicou que o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em evidências”, de modo que **um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela**, pois tende a contrariar consenso científico vigente. Mais do que isso: a gestão do SUS, obrigada a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações de saúde, só se torna viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. **Obrigação da rede pública a financiar toda e qualquer ação e**

prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada.

Dessa forma, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida, **sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.**

Com isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que **o deferimento pelo Judiciário de medicamento extraordinário fora do âmbito do SUS, deve ficar restrito a hipóteses de rara e especial excepcionalidade:**

(a) quando a enfermidade do paciente não for tratada pelo SUS, ou;

(b) quando o tratamento/medicamento disponibilizado pelo SUS não tiver eficácia comprovada no caso concreto.

Caso não se inclua nestas hipóteses, **pelo fato de o SUS disponibilizar gratuitamente outros medicamentos para o tratamento da enfermidade**, não há que se falar em deferimento pelo Judiciário, sob pena de prejudicar, conforme já explicitado, o acesso universal e isonômico à saúde. E isto porque a opção pelo medicamento listado leva em consideração outros fatores: **o custo, a eficácia comprovada e a incidência sobre a patologia tratada, de modo a beneficiar a maior parte da população.** Assim, a Administração Pública adota critérios plausíveis quando incorpora um medicamento à listagem daqueles que serão gratuitamente distribuídos, sendo inviável ignorá-los a fim de satisfazer a demanda de uma pessoa isoladamente.

Por tal razão, não cabe ao Judiciário ingerência sobre prioridades estabelecidas pelo Estado, que envolvam políticas públicas para garantir o regular atendimento e fornecimento de medicação na rede de saúde, sob pena de, por via transversa, criar situação de inaceitável desigualdade em relação aos demais usuários do SUS. O posicionamento acima é compartilhado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

*CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. União, Estados e Municípios, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são responsáveis solidários pelo fornecimento de medicamentos. **Não faz jus ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público o paciente que não se desincumbe de comprovar a real necessidade dos mesmos e a impossibilidade de substituí-los por outros disponibilizados pelo SUS.** Inversão da sucumbência, que é fixada na esteira dos precedentes da Turma. Prequestionamento estabelecido pelas razões de decidir. Apelações e remessa oficial providas. (apelação nº 0006160-45.2008.404.7200)*

Conclui-se, portanto, que é necessário demonstrar que **o tratamento fornecido pelo SUS não é adequado para controle da enfermidade da parte requerente para que, então, possa se fugir ao padrão e deferir terapia diversa, não havendo margem para escolha de tratamento que mais lhe aprouver**, desconsiderando as terapias já ofertadas pela Administração Pública, a partir da mera discricionariedade médica, ainda que o profissional esteja vinculado ao SUS.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de representativo de controvérsia (tema 106)[1], no sentido de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença **cumulativa** dos seguintes requisitos[2]:

(a) *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*

(b) **incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;**

(c) *existência de registro na ANVISA do medicamento, **observados os usos autorizados pela agência.***

De outro giro, é dizer: o Superior Tribunal de Justiça ratificou os requisitos já fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange à prova de ineficácia do tratamento dispensado pelo SUS, e incluiu 2 novos, quais seja, a hipossuficiência econômica do requerente e o registro do medicamento na ANVISA, afastando, assim, o fornecimento de fármacos cuja eficácia não tenha sido atestada por órgãos de controle.

No caso concreto, trata-se de Autor, portador de diabetes mellitus tipo 1, com grande labilidade glicêmica (evento 1, ANEXO2 - Página 18), solicitando o fornecimento do equipamento Freestyle Libre e sensor (evento 1, ANEXO2 - Página 8).

Conforme Parecer do NAT-JUS (evento 11, PARECER1 destes autos), segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, para atingir o bom controle glicêmico é necessário que os pacientes realizem avaliações periódicas dos seus níveis glicêmicos. O automonitoramento do controle glicêmico é uma parte fundamental do tratamento **e este pode ser realizado através da medida da glicose no sangue capilar (teste padronizado pelo SUS) ou pela monitorização contínua da glicose (MGC).** Ponderou que **o método de monitorização Free Style® Libre não está incorporado ao SUS, bem como os estudos científicos sobre essa modalidade de monitorização até o momento não apresentaram evidências de benefício inequívoco** para a recomendação de sua incorporação ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da DM tipo 1, segundo avaliação do Ministério da Saúde. Assim, concluiu que o aparelho FreeStyle® Libre apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico do Autor, Diabetes mellitus tipo 1, com grande variabilidade glicêmica (evento 11, PARECER1, Página 18), **NÃO É IMPRESCINDÍVEL. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.**

De fato, a documentação médica apresentada não apresentou qualquer fundamento para afastar a forma convencional de aferição pela glicemia capilar, método fornecido pelo SUS.

Portanto, quanto aos insumos requeridos, tem-se pela negativa de seu fornecimento.

[1] Lei nº 8.080/90:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea *d* do inciso I do art. 6º consiste em: **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravamento à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

[2] ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glauco 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: **Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106).** Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. **TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015** A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a **presença cumulativa dos seguintes requisitos:** (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-**

RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5060388-66.2024.4.02.5101

510015013637 .V3